Клинические рекомендации

Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.1** — Хронический назофарингит **J35.1** — Гипертрофия миндалин **J35.2** — Гипертрофия аденоидов **J35.3** — Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/662_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

2.5 Жалобы и анамнез 5

3. Диагностика 5

3.1 Осмотр 5

3.2 Эндоскопия полости носа и носоглотки 5

3.3 Рентгенография носоглотки 6

3.4 Компьютерная томография 6

3.5 Тимпанометрия 6

3.6 Исследования, которые не показаны 6

3.7 Консультации специалистов 6

4. Лечение 7

4.1 Тактика 7

4.2 Аденотомия 8

4.3 Тонзиллотомия, сочетанная операция, тонзиллэктомия у взрослых 8

4.4 Консервативное лечение аденоидита 9

4.5 Послеоперационное обезболивание 10
4.6 Послеоперационное ведение 10
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 10
5.1 Профилактика 10
5.2 Показания к госпитализации и выписке 11
5.3 Факторы, влияющие на исход лечения 11
6. Источник и актуальность 11
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Наличие у ребёнка глоточной и нёбных миндалин само по себе не является патологией. Показанием к обследованию служат жалобы, клинические проявления или сопутствующее заболевание, на течение которого могут влиять аденоиды и нёбные миндалины.
- Диагноз:
  1. гипертрофия нёбных миндалин: жалобы, анамнез, фарингоскопия с обязательной оценкой нижнего полюса миндалин;
  2. гипертрофия аденоидов: дополнительно инструментальное подтверждение: эндоскопия носоглотки, рентгенография носоглотки или компьютерная томография (КТ).
- Пальцевое исследование носоглотки для диагностики аденоидов у детей не проводится.
- Тактика:
  1. есть показания: операция в плановом порядке;
  2. нет показаний или есть абсолютные противопоказания: динамическое наблюдение оториноларинголога.
- Консервативное лечение детям с гипертрофией аденоидов: только при признаках аденоидита. У детей **младше 7–9 лет** без осложнений и значимого влияния на качество жизни аденоидит не считается патологией: наблюдение.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. гипертрофия аденоидов: увеличение глоточной миндалины со стойким затруднением носового дыхания и (или) осложнениями: обструктивные нарушения сна, экссудативный средний отит, деформация лицевого скелета;
2. гипертрофия нёбных миндалин: увеличение одной или обеих нёбных миндалин; бессимптомно или с храпом, остановками дыхания во сне, нарушениями глотания и артикуляции, деформацией лицевого скелета.

Аденоидит: реактивные воспалительные изменения глоточной миндалины как органа местного иммунитета в ответ на антигены, попадающие на слизистую носа и глотки. У детей **младше 7–9 лет** без значимого влияния на качество жизни и без осложнений (например, средних отитов) аденоидит не считается патологией.

Острый синусит считается рецидивирующим при 4 и более эпизодах за последний год. Острый средний отит считается рецидивирующим при 3 и более эпизодах за 6 месяцев или 4 и более эпизодах за 12 месяцев.

2.2 Этиология

1. наиболее вероятные причины: вирусная инфекция, генетическая предрасположенность, факторы окружающей среды;
2. роль бактериальной инфекции, гастроэзофагеального рефлюкса и аллергии дискутабельна;
3. как правило, действует несколько факторов одновременно.

Особое внимание уделяется вирусу герпеса IV типа: герпетическая инфекция является одной из частых причин выраженной гипертрофии глоточной миндалины со стойкой обструкцией носоглотки.

2.3 Классификация

Классификация А. Г. Лихачёва: какую часть сошника прикрывает ткань глоточной миндалины.

1. I степень: не более верхней трети сошника;
2. II степень: от 1/3 до 2/3;
3. III степень: более 2/3.

Классификация Б. С. Преображенского: расстояние от вертикали через середину язычка до края передней (нёбно-язычной) дужки делят на три части.

1. I степень: миндалина занимает треть расстояния;
2. II степень: две трети;
3. III степень: миндалины достигают язычка и соприкасаются.

2.4 Клиническая картина

Жалобы и симптомы чаще всего отмечаются при гипертрофии III степени. При I и II степени пациенты, как правило, хотя и не всегда, жалоб не предъявляют.

Гипертрофия нёбных миндалин

1. храп: постоянный, часто не зависит от положения тела во сне (в отличие от храпа при воспалении);
2. в ряде случаев признаки синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС): дневная сонливость, снижение успеваемости;
3. значительно реже изменения прикуса и лёгкая дисфония.

Гипертрофия аденоидов

1. нарушения дыхания во сне;
2. стойкое затруднение носового дыхания: постоянно открытый рот, гипоназальность (закрытая гнусавость), сухость во рту;
3. снижение слуха при экссудативном среднем отите, повторные острые средние отиты;
4. даже при II степени после простуды заложенность, постназальный затёк и кашель **до нескольких недель**;
5. у школьников частые, в том числе рецидивирующие, острые синуситы.

Аденоидит

1. основная жалоба: кашель, как правило продуктивный, ночной и утренний (постназальный затёк);
2. может развиваться и при небольших размерах глоточной миндалины;
3. при гипертрофии аденоидов II–III степени одновременно заложенность носа и кашель.

Реактивные изменения глоточной миндалины после простуды или на фоне аллергического ринита у детей **младше 7–9 лет** физиологичны, если:

1. нет осложнений (средних отитов, острого синусита);
2. кашель или затруднение носового дыхания не нарушают сон и дневную активность.

Симптомы не патогномоничны.

Дифференцируют с

1. острым и хроническим риносинуситом;
2. аллергическим, вазомоторным и гипертрофическим ринитом;
3. искривлением перегородки носа;
4. инородными телами и новообразованиями полости носа и носоглотки.

Гипертрофия аденоидов часто сопутствует острому и хроническому синуситу и аллергическому риниту.

Клиническая картина у взрослых не отличается от таковой у детей.

2.5 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. длительность заболевания и с чем связано начало;
2. динамику жалоб и их влияние на сон и дневную активность;
3. проводившееся лечение, его эффект и нежелательные явления;
4. сохраняются ли симптомы вне эпизодов ОРВИ и как выражены сейчас по сравнению с прошлым;
5. сопутствующие, прежде всего аллергические, заболевания: наблюдение, лечение, планируемые операции;
6. перенесённые операции и манипуляции в полости носа, включая назотрахеальную интубацию и назальные зонды.

---

3. Диагностика

Наличие у ребёнка глоточной и нёбных миндалин не является патологией.

Обследование оправдано при

1. жалобах;
2. клинических проявлениях;
3. сопутствующем заболевании, на которое могут влиять аденоидит, гипертрофия аденоидов или нёбных миндалин.

1. гипертрофия нёбных миндалин: жалобы, анамнез, физикальное обследование с фарингоскопией и обязательной оценкой нижнего полюса миндалин;
2. гипертрофия аденоидов: дополнительно эндоскопия носоглотки, рентгенография носоглотки или КТ.

3.1 Осмотр

Показания

1. каждый пациент: осмотр оториноларинголога (амбулаторно и при госпитализации).

Пальцевое исследование носоглотки детям в амбулаторной практике не проводят: результаты крайне субъективны, процедура неприятна и может травмировать структуры глотки.

Лабораторные исследования для диагностики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин не применяют; их используют лишь для диагностики сопутствующих заболеваний.

3.2 Эндоскопия полости носа и носоглотки

Показания

1. симптомы, характерные для гипертрофии аденоидов.

Метод первого выбора, в том числе для контроля после операции.

1. предпочтителен гибкий эндоскоп с сохранением изображения (фото или видео);
2. метод первого выбора для дифференциальной диагностики и оценки носоглотки после операции, в том числе в отдалённые сроки;
3. ригидный эндоскоп дети, особенно дошкольники, переносят хуже;
4. осмотр без сохранения изображения значительно менее объективен при последующих консультациях.

3.3 Рентгенография носоглотки

Показания

1. симптомы, характерные для гипертрофии аденоидов: оценка размеров глоточной миндалины (боковая проекция).

Метод является недорогим, доступным и безболезненным. К недостаткам относятся небольшая лучевая нагрузка, необходимость правильной укладки с открытым ртом и невозможность дифференцировать аденоиды от других объёмных образований носоглотки; результат не всегда соответствует выраженности симптомов. После аденотомии рентгенография малоинформативна, поскольку не позволяет отличить аденоиды от компенсаторной гипертрофии трубных валиков и оценить рубцовые изменения.

3.4 Компьютерная томография

Показания к КТ верхних дыхательных путей и шеи

1. сложные случаи: дифференциальная диагностика гипертрофии аденоидов с другой патологией носа со сходными симптомами;
2. одновременная диагностика нескольких заболеваний.

3.5 Тимпанометрия

Показания

1. гипертрофия аденоидов: объективная оценка среднего уха.

3.6 Исследования, которые не показаны

Мазки из глотки на микрофлору для диагностики гипертрофии миндалин не показаны: условно-патогенные бактерии есть и у здоровых, рост или его отсутствие не говорит о риске и прогнозе.

3.7 Консультации специалистов

Консультация аллерголога-иммунолога

1. клинические и анамнестические признаки аллергического ринита;
2. атопическая бронхиальная астма;
3. атопический дерматит.

В первую очередь при

1. глазных симптомах, повторяющемся чихании и зуде в носу;
2. ринологических симптомах, связанных с цветением, животными или другими ситуациями;
3. повторных приступах кашля, свистящего или затруднённого дыхания, стеснения в груди, особенно ночью и рано утром;
4. атопическом дерматите, крапивнице и других аллергических заболеваниях кожи;
5. рецидивирующих острых средних отитах или риносинуситах.

Консультация специалиста по расстройствам сна

1. признаки повторяющихся обструктивных нарушений сна.

Консультация ортодонта

1. врождённые или приобретённые изменения челюстно-лицевой области.

Консультация инфекциониста

1. подозрение на персистирующую вирусную, прежде всего герпесвирусную, инфекцию.

Показание: хотя бы один признак, сохраняющийся **3 месяца и более**:

1. увеличение лимфатических узлов в 3 группах и более (не менее 3 узлов в каждой);
2. увеличение печени и (или) селезёнки;
3. абсолютное число нейтрофилов ниже возрастной нормы и (или) общее число нейтрофилов ниже 5×10^9/л.

Оториноларинголог оценивает симптомы, решение о лабораторном поиске вирусов принимает инфекционист.

---

4. Лечение

4.1 Тактика

1. есть показания: хирургическое лечение в плановом порядке;
2. нет показаний или есть абсолютные противопоказания: динамическое наблюдение оториноларинголога;
3. хроническая или врождённая сопутствующая патология: операция только по согласованию с профильным специалистом.

Абсолютные противопоказания к операции

1. шок;
2. острая стадия инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения;
3. поздние стадии тяжёлых инфекционных и онкологических заболеваний;
4. тяжёлое, крайне тяжёлое или терминальное состояние из-за сопутствующих заболеваний.

Относительные противопоказания

1. неконтролируемое или плохо контролируемое течение сопутствующей соматической патологии;
2. аномалии строения носа, резко повышающие риск серьёзных интраоперационных осложнений.

Консервативное лечение оправдано только при клинических и анамнестических признаках воспаления глоточной миндалины (аденоидита) или нёбных миндалин (тонзиллита) при наличии соответствующих жалоб или осложнений.

4.2 Аденотомия

Аденотомия: восстановление проходимости носоглотки при отсутствии противопоказаний.

Показания к аденотомии у детей

1. частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна: храп, в ряде случаев дневная сонливость и вялость;
2. экссудативный средний отит **3 месяца**, резистентный к консервативному лечению и подтверждённый тимпанометрией;
3. рецидивирующие острые средние отиты или острые синуситы (**3 эпизода и более за 6 месяцев** или **4 и более за 12 месяцев**) после исключения других причин, прежде всего иммунодефицита, и при неэффективности медикаментозной профилактики;
4. хронический синусит с выраженными симптомами или частыми обострениями при неэффективности **1–2 курсов** консервативного лечения;
5. стойкое затруднение носового дыхания без других причин, ухудшающее качество жизни или ведущее к деформации лицевого скелета (цефалометрия, заключение ортодонта или челюстно-лицевого хирурга);
6. заключение других специалистов об аденотомии как этапе лечения сопутствующего заболевания (например, перед кардиохирургическим вмешательством).

Ориентир при объективной оценке нарушений сна: индекс апноэ-гипопноэ.

1. **5–15**: среднетяжёлая форма;
2. **более 15**: тяжёлая форма.

Детям аденотомию предпочтительно выполнять под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

4.3 Тонзиллотомия, сочетанная операция, тонзиллэктомия у взрослых

Тонзиллотомия детям с гипертрофией нёбных миндалин: уменьшение размеров миндалин.

Показание

1. частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна (храп, в ряде случаев дневная сонливость и вялость); ориентир: индекс апноэ-гипопноэ, как при аденотомии.

При одновременном наличии у ребёнка показаний и к тонзиллотомии, и к тонзиллэктомии предпочтение отдаётся тонзиллэктомии. Тонзиллотомию предпочтительно проводить под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

Сочетанная гипертрофия аденоидов и нёбных миндалин: аденотомия с тонзиллотомией по показаниям к аденотомии.

Такое вмешательство проводится только под общим обезболиванием с обязательным визуальным контролем операционного поля; в раннем послеоперационном периоде пациент находится под наблюдением в ЛОР-отделении стационара.

Взрослые с гипертрофией нёбных миндалин и синдромом обструктивного апноэ сна: тонзиллэктомия при отсутствии противопоказаний.

> Для рекомендации о тонзиллэктомии у взрослых не указаны ни уровень убедительности рекомендаций, ни уровень достоверности доказательств. Кроме того, в разделах о госпитализации, послеоперационном обезболивании и реабилитации речь идёт только об аденотомии и тонзиллотомии, тонзиллэктомия у взрослых не упоминается.

4.4 Консервативное лечение аденоидита

Консервативное лечение детей с гипертрофией аденоидов: только при признаках аденоидита.

Признаки аденоидита

1. продуктивный кашель вследствие постназального затёка;
2. выделения из носа;
3. периодическое затруднение носового дыхания.

У детей **младше 7–9 лет** без значимого влияния на сон, приём пищи и дневную активность и без осложнений (например, средних отитов): наблюдение.

1. Промывание (орошение) полости носа всем пациентам с аденоидитом.
    1. 1–2 раза в день изотоническими или гипертоническими (1,5–3%) солевыми растворами на основе морской воды;
    2. облегчает туалет полости носа, уменьшает симптомы, улучшает условия для местных препаратов;
    3. детям дошкольного возраста промывание большими объёмами не рекомендуется: высокий риск средних отитов.
2. Местные антибактериальные препараты по специальным показаниям.

    Показания

    1. слизисто-гнойные выделения из носа и по задней стенке глотки в течение всего дня;
    2. отсутствие улучшения **за 7–10 дней** противовоспалительной терапии.

    Препараты (курс до 7 дней)

    1. назальный спрей фрамицетина;
    2. дексаметазон + неомицин + полимиксин B + фенилэфрин: детям **старше 2,5 года**;
    3. тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат: раствор для ингаляций.

    Введение в полость носа растворов антибиотиков, предназначенных для парентерального, внутриконъюнктивального или ушного применения, не рекомендуется: они не предназначены для полости носа и могут нарушать мукоцилиарный транспорт.
3. Карбоцистеин и другие мукорегулирующие препараты пациентам **старше 2 лет**.
    1. карбоцистеин в форме сиропа, в том числе карбоцистеина лизина моногидрат, курсом **от 1 до 3 месяцев**;
    2. уменьшает постназальный затёк и повышает вероятность разрешения сопутствующего экссудативного среднего отита;
    3. при монотерапии отличие от выжидательной тактики заметно лишь к 2–3-й неделе;
    4. другие муколитики, в том числе местные, одновременно не назначают: усиливают затёк.
4. #Мометазон назальный спрей по 50 мкг в каждый носовой ход 1 раз в сутки, **1–3 месяца**: детям **старше 2 лет** при сопутствующем аллергическом рините.

    Ни гипертрофия аденоидов, ни аденоидит, ни назофарингит не зарегистрированы в России в качестве показания ни для одного топического глюкокортикостероида; знак # обозначает применение вне инструкции по медицинскому применению.

Не рекомендуются

Масла, в первую очередь масло туи, при гипертрофии аденоидов и аденоидите не применяются: их эффективность не доказана, а в полости носа они угнетают функцию ресничек мерцательного эпителия, нарушают эвакуацию секрета и повышают риск бактериальной инфекции.

Ежедневное промывание полости носа растворами антисептиков не рекомендуется: эффективность не доказана, нарушается мукоцилиарный транспорт, возможны местные дисбиотические изменения.

4.5 Послеоперационное обезболивание

После аденотомии и (или) тонзиллотомии: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или парацетамол.

Показания к обезболиванию

1. жалобы на боль;
2. отказ от еды и питья;
3. повторная рвота и тошнота.

Препарат	Доза у детей
Ибупрофен	8–10 мг/кг на приём, не более 30 мг/кг в сутки, внутрь в лекарственной форме, соответствующей возрасту (таблетки, покрытые оболочкой, — с 6 лет); детям младшего возраста — ректальные суппозитории.
Кетопрофен	С 6 лет — гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь (кетопрофена лизиновая соль), 40 мг на приём до 3 раз в день.
Парацетамол	10–15 мг/кг на приём, не более 60 мг/кг в сутки, в любой лекарственной форме, соответствующей возрасту. При невозможности приёма внутрь и отсутствии суппозиториев — парентерально 15 мг/кг на введение.

4.6 Послеоперационное ведение

Осмотр оториноларинголога после аденотомии и (или) тонзиллотомии: перед выпиской и амбулаторно **через 7–14 дней** после выписки.

Охранительный режим **5–7 дней** после операции.

1. ограничение контактов: не посещать детский коллектив и людные места;
2. ограничение физической нагрузки;
3. исключение перегревания, особенно головы и шеи, в том числе горячей пищи и питья.

Дисфония **более месяца** после операции: направление к логопеду-дефектологу.

Симптомы обструктивных нарушений сна **более 6–8 недель** после операции: направление к специалисту по расстройствам сна.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Специфическая профилактика гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин отсутствует. Поскольку важную роль играют респираторные вирусы, следует соблюдать общие правила профилактики острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Ряд лекарственных препаратов может применяться для плановой и экстренной профилактики аденоидита у детей.

Детям **старше 1 года** из групп риска по респираторным инфекциям рекомендованы стандартизированные растительные препараты для приёма внутрь из группы прочих антисептиков для профилактики эпизодов ОРВИ, а также для сокращения длительности и уменьшения тяжести последующих эпизодов аденоидита.

К ним относятся препараты, содержащие корень алтея, цветки ромашки, хвощ, листья грецкого ореха, тысячелистник, кору дуба и одуванчик лекарственный. Они назначаются также для лечения аденоидита при появлении симптомов ОРВИ в качестве монотерапии или в комплексе.

Детям **старше 3 лет** при появлении симптомов острого назофарингита применяют комбинированный препарат лизоцим + пиридоксин для сокращения длительности и уменьшения тяжести последующего аденоидита.

Детям из групп риска по респираторным инфекциям: лизаты бактерий для сокращения длительности и тяжести эпизодов аденоидита и осложнений.

Плановая профилактика курсами по инструкции **2–3 раза в год**, пероральные и местные формы.

Для профилактики аденоидитов и их осложнений у детей может рассматриваться применение местных пробиотиков на основе бактерий нормальной микрофлоры глотки.

Обратиться к врачу, если после простуды **2 недели и более** сохраняются:

1. заложенность носа;
2. храп;
3. снижение слуха;
4. кашель (при исключённой патологии нижних дыхательных путей).

5.2 Показания к госпитализации и выписке

Показание к госпитализации

1. плановая аденотомия и (или) тонзиллотомия при наличии показаний и отсутствии противопоказаний.

Аденоидит лечат амбулаторно или в консультативно-диагностическом отделении.

Выписка после операции

1. удовлетворительное общее состояние;
2. отсутствие осложнений.

5.3 Факторы, влияющие на исход лечения

Влияют на исход операции

1. хронические соматические заболевания: возможно обострение в раннем послеоперационном периоде;
2. аллергический ринит: выше вероятность неполного регресса назальных симптомов (передней и задней ринореи, в меньшей степени заложенности);
3. ожирение: выше вероятность сохранения обструктивных нарушений сна;
4. гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: выше вероятность сохранения назальных симптомов и риск инфекционных осложнений.

При гипертрофии нёбных миндалин медикаментозное лечение аденоидита крайне малоэффективно в отношении обструктивных нарушений сна.

При наличии у ребёнка сопутствующего заболевания, способного повлиять на результат операции, врач должен проинформировать об этом пациента или родителей до операции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	662_2 · открыть текст КР ↗

Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Рекомендация о тонзиллэктомии взрослым с гипертрофией нёбных миндалин и СОАС дана без уровня убедительности рекомендаций и уровня достоверности доказательств, а в разделах о госпитализации, обезболивании и реабилитации упоминаются только аденотомия и тонзиллотомия.
- Для хронического аденоидита в разделе 1.4 предложены два кода: J31.1 («как возможный вариант кодирования») и J35.8 («например, аденоидит»).
- В комментарии к ибупрофену фраза о суппозиториях оборвана («ректальные суппозитории (у детей младше) 2 лет»), поэтому возрастная граница неоднозначна.